

KlinikIQ Clinical/Scientific Rationales Ultra Rewritten - Report

Scope: standard clinical cases under Klinik Branş Seç / Klinik Vakalar / Olgular / Diğer Olgular. TUS Spot Olgular / ai-spot records were excluded and hash-verified as untouched.

The right-column “Klinik/Bilimsel gerekçe” display sources were rewritten from case-specific clues, the correct answer logic, mechanism/clinical reasoning, and concise differential contrast.

Key Metrics

Metric	Value
Clinical cases scanned	410
Rationale fields found	2050
Rationales rewritten	2050
Bad templates cleaned	700
Wrong-option-focused rationales corrected	733
Ancak da / language errors cleaned	83
hedef mekanizma / hedef patern terms cleaned	384
Broken/half sentences corrected	83
Generic/irrelevant rationales cleaned	222
Post-update bad target rationale count	0
Scientific concerns	0
ID changed	False
Correct-answer logic preserved	True
TUS Spot untouched	True

Branch Rewrite Summary

Branch	Cases	Rationales rewritten
Küçük Stajlar	28	140
İç Hastalıkları	26	130
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları	98	490
Kadın Hastalıkları ve Doğum	28	140
Genel Cerrahi	27	135
Tıbbi Farmakoloji	28	140
Tıbbi Patoloji	28	140
Anatomi	29	145
Tıbbi Biyokimya	30	150
Fizyoloji	30	150
Histoloji ve Embriyoloji	28	140
Tıbbi Mikrobiyoloji	30	150

Representative Coverage Samples

v163-new-001-akut-sistemik-reaksiyon | Küçük Stajlar | Akut sistemik reaksiyon

Question: Antibiyotik enjeksiyonundan dakikalar sonra ürtiker, dudak ödemi, hışıltı ve hipotansiyon gelişen bu hastada ilk özgül acil tedavi hangisidir?

Correct answer: İntramüsküler adrenalin uygulanması

New clinical/scientific rationale:

Vakada antibiyotik enjeksiyonundan 10 dakika sonra çoklu sistem bulgularının başlaması, yaygın ürtiker ve dudak ödeme hışıltı ve oksijen satürasyonunda düşmenin eşlik etmesi ve hipotansiyon ve yüksek şok indeksinin dolaşım etkilenmesini göstermesi İntramüsküler adrenalin uygulanmasını gerektirir. Anafilakside antihistaminik, steroid ve beta-2 agonist yardımcıdır; hipotansiyon veya bronkospazm varken ilk basamak intramüsküler adrenalindir. Ayırıcı tanıda antihistaminikler kaşıntı ve ürtiker kontrolünde yardımcı olabilir; buna karşılık vakadaki antibiyotik enjeksiyonundan 10 dakika sonra çoklu sistem bulgularının başlaması ve yaygın ürtiker ve dudak ödeme hışıltı ve oksijen satürasyonunda düşmenin eşlik etmesi

bu olasılığı geri plana iter.

v163-new-002-acil-elektrolit-bozuklugu | İç Hastalıkları | Acil elektrolit bozukluğu

Question: Kronik böbrek hastalığı zemininde ağır hiperkalemi ve EKG değişikliği bulunan bu hastada ilk acil yaklaşım hangisidir?

Correct answer: İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi

New clinical/scientific rationale:

Vakada kronik böbrek hastalığı ve ACE inhibitörü kullanımı potasyum atılımını azaltarak hiperkalemi riskini artırması ve potasyumun 7.1 mmol/L olması ve EKG’de sivri T dalgaları/QRS genişleme eğilimi aritmi tehdidini göstermesi İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesini gerektirir. Hiperkalemi + EKG değişikliği = ilk basamak IV kalsiyum; insülin-glukoz ve beta-agonist potasyumu düşürür ama kalsiyumun yerini tutmaz. Ayırıcı tanıda insülin-glukoz potasyumu hücre içine kaydırarak serum potasyumunu düşürür ve erken tedavinin önemli parçasıdır; buna karşılık vakadaki kronik böbrek hastalığı ve ACE inhibitörü kullanımı potasyum atılımını azaltarak hiperkalemi riskini artırması ve potasyumun 7.1 mmol/L olması ve EKG’de sivri T dalgaları/QRS genişleme eğilimi aritmi tehdidini göstermesi bu olasılığı geri plana iter.

v163-new-003-atesli-dokuntulu-cocuk | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Ateşli döküntülü çocuk

Question: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

Correct answer: Neisseria meningitidis

New clinical/scientific rationale:

Vakada yüksek ateş, ense sertliği ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyon düşündürülen bulguların bulunması, basmakla solmayan purpurik döküntülerin fulminan bakteriyemi saptanması ve lökositoz (23.000/mm³) saptanması etken olarak Neisseria meningitidis’i ön plana çıkarır. Purpurik döküntü, hızlı sepsis bulguları ve meningeal irritasyon birlikteliği meningokoksemi/menenjit için ayırt edicidir. Ayırıcı tanıda Streptococcus pneumoniae düşünülebilir; buna karşılık vakadaki yüksek ateş, ense sertliği ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyon düşündürülen bulguların bulunması ve basmakla solmayan purpurik döküntülerin fulminan bakteriyemi saptanması bu olasılığı geri plana iter.

v163-new-004-gebelikte-akut-karin | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Gebelikte akut karın

Question: Hemodinamik instabilite, pozitif beta-hCG, intrauterin gebelik kesesinin izlenmemesi ve serbest sıvı saptanan bu hastada en uygun acil yaklaşım hangisidir?

Correct answer: Acil cerrahi eksplorasyon

New clinical/scientific rationale:

Vakada pozitif beta-hCG ile birlikte intrauterin gebelik kesesinin izlenmemesi, gebeliğin bilinmeyen lokalizasyonu içinde ektopik gebeliği ön plana çıkarması ve hipotansiyon, taşikardi ve senkop hissi rüptür ve intraperitoneal kanama olasılığını göstermesi Acil cerrahi eksplorasyon yaklaşımını gerektirir. Ektopik gebelikte stabilite yönetimi belirler: rüptür veya hemodinamik instabilite varsa seri beta-hCG ya da metotreksat değil, acil cerrahi ve resüsitasyon önceliklidir. Ayırıcı tanıda metotreksat, hemodinamik olarak stabil, rüptür bulgusu olmayan ve yakın izleme uygun seçilmiş ektopik gebeliklerde kullanılabilir; buna karşılık vakadaki pozitif beta-hCG ile birlikte intrauterin gebelik kesesinin izlenmemesi, gebeliğin bilinmeyen lokalizasyonu içinde ektopik gebeliği ön plana çıkarması bu olasılığı geri plana iter.

v163-new-006-sag-alt-kadran-agrisi | Genel Cerrahi | Sağ alt kadranda ağrısı

Question: Göç eden sağ alt kadranda ağrısı, lokal periton irritasyonu, inflamasyon yüksekliği ve USG’de komprese olmayan genişlemiş apandiks saptanan bu hastada en olası tanı hangisidir?

Correct answer: Akut apandisit

New clinical/scientific rationale:

Vakada ağrının periumbilikal bölgeden sağ alt kadrana göç etmesi apandisit tipik visseral-somatik ağrı geçişini düşündürmesi ve McBurney hassasiyeti, lokal rebound ve defans sağ alt kadranda lokal periton irritasyonunu göstermesi Akut apandisit tanısını ön plana çıkarır. Sağ alt kadranda ağrısı sorularında göç eden ağrı + McBurney/rebound + komprese olmayan geniş apandiks üçlüsü akut apandisit güçlü biçimde destekler. Ayırıcı tanıda meckel divertikülü sağ alt kadranda ağrısı yapabilir ve apandisit taklit edebilir; buna karşılık vakadaki ağrının periumbilikal bölgeden sağ alt kadrana göç etmesi apandisit tipik visseral-somatik ağrı geçişini düşündürmesi bu olasılığı geri plana iter.

v163-new-007-kolinergik-bulgularla-zehirlenme | Tıbbi Farmakoloji | Kolinergik bulgularla zehirlenme

Question: Organofosfat maruziyeti sonrası miyozis, bronkore ve fasikülasyon gelişen bu hastada pralidoksimin temel tedavi edici mekanizması hangisidir?

Correct answer: Asetilkolinesteraz enzimini yeniden aktive etmesi

New clinical/scientific rationale:

Vakada kapalı alanda insektisit maruziyeti öyküsü, organofosfat toksisitesi için güçlü farmakolojik bağlam oluşturması ve miyozis, bronkore, salivasyon ve bradikardi muskarinik asetilkolin fazlalığını göstermesi Asetilkolinesteraz enzimini yeniden aktive etmesi yaklaşımını gerektirir. Organofosfat zehirlenmesinde atropin muskarinik bulguları bloke eder; pralidoksime ise asetilkolinesterazı reaktif ederek özellikle nikotinik bulgular için mekanistik antidottur. Ayırıcı tanıda bu mekanizma atropine aittir; sekresyon ve bronkoreyi azaltır; buna karşılık vakadaki kapalı alanda insektisit maruziyeti öyküsü, organofosfat toksisitesi için güçlü farmakolojik bağlam oluşturması ve miyozis, bronkore, salivasyon ve bradikardi muskarinik

asetilkolin fazlalığını göstermesi bu olasılığı geri plana iter.

v163-new-008-kronik-malabsorpsiyon-tablosu | Tıbbi Patoloji | Kronik malabsorpsiyon tablosu

Question: Glutenle ilişkili kronik malabsorpsiyon, pozitif anti-tTG IgA ve duodenum biyopsisi yapılan bu hastada beklenen temel histopatolojik bulgu hangisidir?

Correct answer: Villus atrofi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı

New clinical/scientific rationale:

Vakada gluten içeren öğünlerden sonra artan şişkinlik ve kötü kokulu dışkılama malabsorpsiyon paternini desteklemesi ve tekrarlayan demir eksikliği ve pozitif anti-tTG IgA çölyak hastalığı olasılığını güçlendirir bulunması Villus atrofi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı kararını ön plana çıkarır. Çölyakta yüksek getirili histoloji üçlüsü villus atrofi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışıdır; ülseratif kolitte kript apseleri, Crohn'da transmural granülom beklenir. Ayırıcı tanıda kript apseleri ve rektumdan başlayan devamlı mukozal tutulum ülseratif koliti düşündürür; buna karşılık vakadaki gluten içeren öğünlerden sonra artan şişkinlik ve kötü kokulu dışkılama malabsorpsiyon paternini desteklemesi ve tekrarlayan demir eksikliği ve pozitif anti-tTG IgA çölyak hastalığı olasılığını güçlendirir bulunması bu olasılığı geri plana iter.

v163-new-009-omuz-travmasi-sonrasi-guc-kaybi | Anatomi | Omuz travması sonrası güç kaybı

Question: Bu hastada omuz abduksiyon kaybı ve deltoid bölge duyu azalmasını en doğrudan açıklayan sinir hasarı hangisidir?

Correct answer: Nervus axillaris

New clinical/scientific rationale:

Vakada düşme sonrası humerus cerrahi boyun bölgesinde kırık hattı izlenmesi nervus axillarisin komşu seyrini risk oluşturması ve omuz abduksiyonunun 15 dereceden sonra zayıflaması deltoid kas fonksiyon kaybını göstermesi Nervus axillaris hasarını ya da anatomik lokalizasyonunu düşündürür. Humerus cerrahi boyun travması + 15 dereceden sonra abduksiyon zayıflığı + deltoid rozet alanında duyu azalması birlikte nervus axillaris hasarını düşündürür. Ayırıcı tanıda nervus suprascapularis supraspinatus ve infraspinatus kaslarını innerve eder; omuz abduksiyonunun başlangıcı ve dış rotasyon etkilenir; buna karşılık vakadaki düşme sonrası humerus cerrahi boyun bölgesinde kırık hattı izlenmesi nervus axillarisin komşu seyrini risk oluşturması ve omuz abduksiyonunun 15 dereceden sonra zayıflaması deltoid kas fonksiyon kaybını göstermesi bu olasılığı geri plana iter.

v163-new-010-acilikla-belirginlesen-metabolik-tablo | Tıbbi Biyokimya | Açıklıkla belirginleşen metabolik tablo

Question: Açıklıkla tetiklenen hipoglisemiye laktat, ürik asit ve trigliserid yüksekliğinin eşlik ettiği bu hastada temel biyokimyasal defekt hangisidir?

Correct answer: Glukoz-6-fosfataz eksikliği

New clinical/scientific rationale:

Vakada beslenme araları uzadığında gelişen terleme ve nöbet benzeri ataklar ağır açlık hipoglisemisini düşündürmesi ve belirgin hepatomegali, karaciğerde glikojen/yağ birikimiyle giden glikojen depo hastalığı paternini desteklemesi Glukoz-6-fosfataz eksikliği mekanizmasını açıklar. Açlık hipoglisemisi + hepatomegali + laktat/ürik asit/trigliserid yüksekliği von Gierke hastalığını düşündürür; Pompe veya Cori hastalığı aynı biyokimyasal üçlüyü tipik olarak vermez. Ayırıcı tanıda karaciğer glikojen fosforilaz eksikliği glikojen yıkımını başlatan basamağı etkiler ve genellikle daha hafif ketotik hipoglisemi yapar; buna karşılık vakadaki beslenme araları uzadığında gelişen terleme ve nöbet benzeri ataklar ağır açlık hipoglisemisini düşündürmesi bu olasılığı geri plana iter.

v168-new-052-bilinc-bulanikligi-ve-hiponatremi | Fizyoloji | Bilinç bulanıklığı ve hiponatremi

Question: Hipotonik hiponatremiye rağmen idrarın konsantrasyonu kaldığı bu hastada temel fizyolojik mekanizma hangisidir?

Correct answer: ADH etkisiyle principal hücrelerde aquaporin-2 yerleşiminin artması ve serbest su tutulması

New clinical/scientific rationale:

Vakada ciddi hiponatremiye düşük serum osmolalitesinin eşlik etmesi gerçek hipotonik hiponatremiyi göstermesi ve idrar osmolalitesinin yüksek kalması, hipotonik plazmaya rağmen ADH etkisinin baskılanmadığını düşündürmesi ADH etkisiyle principal hücrelerde aquaporin-2 yerleşiminin artması ve serbest su tutulması mekanizmasını açıklar. SIADH mantığında problem sodyum eksikliğinden çok uygunsuz ADH etkisine bağlı serbest su tutulmasıdır; idrar hipotonik olması gerekirken konsantrasyon kalır. Ayırıcı tanıda aldosteron eksikliği hipovolemi, hiperkalemi ve renal sodyum kaybı ile hiponatremiye katkı verebilir; buna karşılık vakadaki ciddi hiponatremiye düşük serum osmolalitesinin eşlik etmesi gerçek hipotonik hiponatremiyi göstermesi ve idrar osmolalitesinin yüksek kalması, hipotonik plazmaya rağmen ADH etkisinin baskılanmadığını düşündürmesi bu olasılığı geri plana iter.

v168-new-053-yenidoganda-santral-siyanoz | Histoloji ve Embriyoloji | Yenidoğanda santral siyanoz

Question: Bu yenidoğanda santral siyanoz, VSD, sağ ventrikül çıkış yolu darlığı ve binici aorta birlikteliği hangi embriyolojik gelişim kusuruyla en iyi açıklanır?

Correct answer: Nöral krest hücrelerinin konotrunkal septuma göç ve katkısında bozulma

New clinical/scientific rationale:

Vakada doğumdan sonra düzelmeyen santral siyanoz bulunması, ekokardiyografide VSD ve pulmoner çıkış yolu darlığı bulunması ve aortun septum üzerinde binici yerleşimi bulunması Nöral krest hücrelerinin konotrunkal septuma göç ve katkısında bozulma kökenini destekler. Fallot tetralojisi gibi konotrunkal anomalilerde ana embriyolojik ipucu nöral krest katkısının bozulmasıdır; VSD + pulmoner stenoz + binici aorta birlikte düşünülmelidir. Ayırıcı tanıda endokardiyal yastık kusurları atriyoventriküler septal defekt ve kapak anomalileriyle ilişkilidir; temel problem AV kanal düzeyindedir; buna karşılık vakadaki doğumdan sonra düzelmeyen santral siyanoz bulunması ve ekokardiyografide VSD ve pulmoner çıkış yolu darlığı bulunması bu olasılığı geri plana iter.

v168-new-055-yenidoğanda-okuler-ve-norolojik-bulgular | Tıbbi Mikrobiyoloji | Yenidoğanda oküler ve nörolojik bulgular

Question: Retinokoroidit, hidrosefali ve yaygın intrakraniyal kalsifikasyonlarla değerlendirilen bu yenidoğanda en olası konjenital enfeksiyon etkeni hangisidir?

Correct answer: Toxoplasma gondii

New clinical/scientific rationale:

Vakada gebelikte iyi pişmemiş et tüketimi ve kedi teması, T. gondii maruziyeti için tipik risk bağlamıdır bulunması ve retinokoroidit ve hidrosefali, konjenital toksoplazmozun klasik klinik bulgularıdır bulunması etken olarak Toxoplasma gondii'i ön plana çıkarır. Konjenital toksoplazmozda retinokoroidit, hidrosefali ve intrakraniyal kalsifikasyon triadı yüksek getirili ipucudur; maternal IgG tek başına tanı koydurmaz. Ayırıcı tanıda CMV konjenital enfeksiyonda periventriküler kalsifikasyon, peteşi, hepatosplenomegali ve sensörinöral işitme kaybı ile öne çıkar; buna karşılık vakadaki gebelikte iyi pişmemiş et tüketimi ve kedi teması, T. gondii maruziyeti için tipik risk bağlamıdır bulunması ve retinokoroidit ve hidrosefali, konjenital toksoplazmozun klasik klinik bulgularıdır bulunması bu olasılığı geri plana iter.